

a3_cda_hub 测试报告

生成时间：2026-05-29 19:22:44

测试时间：2026-05-29 19:22:44

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1906 markers=24

禁用工具 success=True chars=1547 markers=9

工具说明：tool_近况摘要:tool_近况摘要：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_照护洞察:tool_照护洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_风险照护联动:tool_风险照护联动：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_疾病分期洞察:tool_疾病分期洞察：本地序贯疾病分期与 GP
分层照护建议（A0 本地计算）
tool_贝叶斯风险后验:tool_贝叶斯风险后验：贝叶斯后验概率与升级决策阈值（A
0 计算）

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

GP协作专业答复报告

患者姓名：陈萍忠
性别/年龄：女 / 上海籍失智长者
当前状态：返院一周，阿尔茨海默病性痴呆（中重度期），头部外伤恢复中，伴高血压、血脂异常，存在BPSD（拒绝配合康复），家属照护焦虑显著。

一、GP确认意见

基于最新临床信息与智能计算图谱分析，确认以下要点：

1. **疾病分期确认**：

患者处于阿尔茨海默病**中重度期（Stage 4）**，亚型1（以认知-行为-

功能序贯衰退为特征)。生物标志物显示认知功能 (MoCA_inverse Z=1.21) 与整体认知 (cognitive_inverse Z=0.40) 显著受损，NPI总分9分提示轻度行为症状，ADL依赖程度尚未达预期阈值，但功能衰退趋势明确。

2. **当前主要风险**：

- **BPSD升级风险**：30天内后验概率为**42.65%**（高于文献先验36%），主要受认知恶化驱动。
- **跌倒高风险**：30天内后验概率**51.75%**，已发生皮下血肿及皮肤擦伤，合并体位性低血压、夜间如厕需求及环境防护不足。
- **多重用药风险**：联用多奈哌齐、美金刚、奥氮平、劳拉西泮、降脂药等，存在重复录入、名称错误及潜在骨髓抑制（白细胞/血小板偏低）。

3. **照护强度需求**：

照护强度升级概率达**70.4%**，需从常规照护转为**加强监测模式**。

二、精神科会诊决策

建议立即启动精神科会诊，理由如下：

- 患者存在明确BPSD表现（拒绝配合康复），当前使用奥氮平1mg + 劳拉西泮2mg qn，但行为控制效果不佳。
- 贝叶斯模型建议在**返院第7日前完成精神科复核**，以评估：
 - 当前抗精神病药与苯二氮草类药物的必要性与剂量合理性；
 - 是否存在疼痛、感染或睡眠剥夺等可逆诱因；
 - 非药物干预策略的个体化调整空间。

会诊重点：避免过度镇静，优先非药物干预，确保药物使用符合“最低有效剂量、最短疗程”原则。

三、照护目标更新

在原有14天目标基础上，**更新并强化以下目标**：

原目标	更新后目标	依据
-----	-----	-----
优化非药物干预活动 重新设计认知干预方案 ：暂停强制跳舞干预，改为 一对一怀旧疗法+音乐聆听（非参与式） ，每日下午固定时段，时长≤20分钟，观察情绪反应 配合度低，需降低刺激强度		
家属支持 新增：家属照护心理支持计划 ：每周1次社工访谈，提供BPSD应对技巧、自我情绪调节指导 家属焦虑未缓解，影响照护质量		
防跌倒管理 强化夜间安全闭环 ：2		

【禁用工具输出摘录】

GP协作专业答复报告

患者姓名：陈萍忠

日期：2024年X月X日

一、GP确认意见

本人确认患者陈萍忠当前临床状况复杂，符合多学科协同照护指征。基于其阿尔茨海默病性痴呆诊断、近期头部外伤恢复期、合并高血压及血脂异常，以及突出的**行为心理症状（BPSD）——表现为拒绝配合康复训练**，加之**跌倒高风险**与**家属显著照护焦虑**，现有照护方案已不足以应对当前挑战。

同意护理团队提出的建议：**亟需精神科专业介入**，以系统评估BPSD类型（如淡漠、激越、抗拒等），并制定个体化干预策略。同时，应在保障安全前提下，重新设计认知干预路径，避免因强制执行导致抵触加剧。

二、会诊决策

建议立即启动精神科正式会诊，理由如下：

- BPSD已影响基本康复参与，存在功能加速衰退风险；
- 患者处于头部外伤恢复期，需排除创伤后谵妄或情绪障碍叠加；
- 家属焦虑未缓解，可能间接影响患者情绪稳定性；
- 当前非药物干预（如舞蹈活动）虽具个性化基础，但实施方式需精神行为专家指导优化。

会诊重点建议：

- 评估BPSD具体表现及诱因（环境、疼痛、沟通方式等）；
- 审慎考虑短期、低剂量非典型抗精神病药物使用的必要性与风险（尤其注意QT间期，因有起搏器）；
- 提供非药物行为干预模板（如验证疗法、简化指令、节奏性活动调整）；
- 协助制定“行为危机应对预案”。

三、照护目标更新

在原有“保障安全、规律服药、预防跌倒”基础上，**新增以下中期目标（4-6周）**：

| 维度 | 更新目标 |

|-----|-----|

| **患者行为** | BPSD频率降低

≥30%（通过护理行为日志量化）；逐步接受每日10-15分钟结构化活动（如音乐律动）

|

| **认知参与** | 基于舞蹈喜好的干预方案完成重构，并实现每周≥3次自愿参与
|
| **家属支持** | 家属焦虑评分（如GAD-7）下降
≥2分，掌握至少2项应对BPSD的沟通技巧 |
| **医疗协同** |
精神科完成首次评估并出具干预方案；GP每两周复评血压、血脂及药物相互作用 |

四、多方协同分工建议

角色	职责
全科医生（GP）	- 统筹整体照护计划 -
监测心血管风险（起搏器、血压、血脂） -	
审核精神科用药与现有药物的相互作用 - 每两周组织多学科简短同步会议	
精神科团队	- 72小时内完成首次床边评估 -
出具BPSD管理方案（含药物与非药物） - 提供家属心理教育材料	